

Wycofanie i *apatia*

Praktyczny przewodnik dla osoby z objawami negatywnymi i jej rodziny: jak odróżnić chorobę od lenistwa, jak planować mikro kroki, czego oczekiwać.

CZAS: 15 min Do powtarzania · plan tygodniowy

ŹRÓDŁO: Carpenter i in. (1988); Galderisi (2014); Firth i in. (2015); Bellack i in. (2004)

JAK UŻYWAĆ

Wypełnij **tygodniowy plan mikro kroków** (sekcja 4). Skala aktywności PRZED/PO w sekcji 3 — zmierzy realną zmianę po 2 tygodniach. Sekcja 5: list dla bliskiej osoby — co warto, by zrozumiała o objawach negatywnych. Karta uzupełnia handout „Objawy negatywne — ukryty problem”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Objawy negatywne to **nie lenistwo i nie depresja** (choć mogą się nakładać). To *neurobiologiczny deficyt* przetwarzania nagrody i motywacji — mózg nie produkuje wystarczającej aktywności w szlakach dopaminergicznych łączących korę przedczołową z ośrodkami nagrody. Galderisi (2014): leczenie wymaga *długoterminowej, wielokierunkowej* pracy — nie pojedynczej interwencji. Bellack i in. (2004): strukturyzowany trening umiejętności społecznych daje mierzalną poprawę w ciągu 3-6 miesięcy regularnej praktyki.

01 ☉ Co to jest, czym nie jest

MIT

„On jest leniwy. Niech się ogarnie. Inni też mają gorzej. Niech weźmie się w garść. Wystarczyłoby trochę dyscypliny i byłoby OK.”

FAKT

Objaw choroby mózgu. Strauss i in. (2014): obniżona aktywność dopaminowa w szlakach motywacji. Pacjent *chce*, ale mózg nie inicjuje. „Dyscyplina” tu nie pomaga, bo nie ma deficytu woli — jest deficyt *inicjacji*.

02 📋 Skale używane do pomiaru

W klinice i badaniach używane są trzy główne skale. Warto je znać — psychiatra może w dokumentacji odwoływać się do nich, a wynik pomaga śledzić progres.

SANS

Scale for the Assessment of Negative Symptoms

Andreasen (1982). 25 pozycji w 5 grupach. *Klasyczna* — od niej zaczęły się systematyczne pomiary objawów negatywnych.

PANSS-N

część skali PANSS

7 pozycji z większej skali PANSS (Kay, 1987). *Najpopularniejsza* w badaniach klinicznych. Wynik 7–49.

BNSS

Brief Negative Symptom Scale

Kirkpatrick i in. (2011). 13 pozycji, 5 domen. *Nowsza*, rozdziela antycypację i konsumpcję przyjemności.

03 Moja codzienna aktywność

Zaznacz dziś, a za 2 tygodnie zaznacz drugi raz. **Aktywność** = ile rzeczy w ciągu dnia robisz z własnej inicjatywy (poza koniecznymi, jak jedzenie czy higiena). Skala subiektywna.

Aktywność — dziś leżenie cały dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pełne dni

Aktywność — za 2 tygodnie leżenie cały dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pełne dni

04 Tygodniowy plan mikrokroków

Zasada: **jeden mały krok dziennie**. Wykonalny w 10–15 minut. Czas musi być *konkretny* (np. „17:00–17:15”), nie ogólny („po południu”). Bliska osoba może pomóc zacząć — wtedy łatwiej.

PONIEDZIAŁEK

— co i o której

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

WEEKEND

— jedna rzecz na sobotę lub niedzielę

05 Trzy rzeczy, które warto, by rodzina rozumiała

1 · TO NIE WYBÓR

Mózg nie produkuje sygnałów „idź zrobić X”. To samo jak diabelek nie „wybiera”, że ma za mało insuliny. Pomaga zachęta zewnętrzna, nie presja.

2 · MAŁE KROKI DZIAŁAJĄ

„Chodźmy razem na 10 min spacer” zadziała lepiej niż „czemu nic nie robisz?”. Wspólne inicjowanie przezwycięża brak antycypacji.

3 · EMOCJE SĄ OBECNE

Splątany afekt = mniej ekspresji *na zewnątrz*. Wewnątrz emocje często są intensywne. „Obojętność” w twarzy nie znaczy obojętności w sercu.

Klucz: Firth i in. (2015, meta-analiza 10 RCT, ~385 pacjentów): **ćwiczenia aerobowe** 3×/tydz. po 30–40 min redukują objawy negatywne istotnie statystycznie. Wielkość efektu $d \approx 0,4$ — porównywalna z najlepszymi interwencjami farmakologicznymi. Carpenter i in. (1988): wyróżnienie pierwotnych od wtórnych objawów *fundamentalnie zmienia leczenie*: jeśli wtórne (60%), to redukcja leku, antydepresant, IPS — i są szanse na zmianę. Jeśli pierwotne (40%), to długoterminowa rehabilitacja + ćwiczenia + mikrokroki + cierpliwość.